

Protokół *CBTp*

Terapia poznawczo-behawioralna w psychozie — uzupełnienie farmakoterapii rekomendowane przez NICE dla każdej osoby z psychozą.

CZAS: 12 min 16–26 sesji w terapii · 50 min

ŹRÓDŁO: Morrison (2017); Turkington i in. (2006); Wykes i in. (2008); NICE CG178 (2014)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **strukturę protokołu CBTp**: sześć składników terapii, cztery fazy w czasie, czego oczekiwać na każdym etapie. Karta służy do rozmowy z terapeutą lub psychiatrą: czy *mam dostęp do CBTp*? Wypisz pytania na sekcji 4 i zabierz je na następną wizytę.

DLACZEGO TO DZIAŁA

CBTp — terapia poznawczo-behawioralna dla psychozy (ang. *Cognitive Behavioural Therapy for psychosis*) — opracowali Morrison, Turkington i Kingdon. **NICE (2014, CG178)** rekomenduje ją jako leczenie *pierwszego rzutu*, obok farmakoterapii, dla **każdej** osoby z psychozą. Meta-analiza Wykes i in. (2008), 34 randomizowane badania kontrolowane: *wielkość efektu* $d = 0,37$ dla objawów pozytywnych. Turner i in. (2014): CBTp skuteczne także u osób odmawiających leków.

01 Sześć składników protokołu

1 · NORMALIZACJA

„Twoje doświadczenia są zrozumiałe”. Głosy słyszy ok. **5–10%** populacji ogólnej (Beavan, 2011). Normalizacja redukuje wstyd i otwiera dialog.

2 · KONCEPTUALIZACJA

Indywidualna mapa: wyzwalacze → interpretacje → emocje → zachowania podtrzymujące. *Dlaczego u mnie i właśnie teraz.*

3 · RESTRUKTURYZACJA

Łagodne kwestionowanie urojeń: „rozważmy **inne wyjaśnienia**”, nie „to nieprawda”. Bez konfrontacji.

4 · PRACA Z GŁOSAMI

Zmiana *relacji* z głosem, nie usuwanie go. „Kto mówi?”, „Jakie mam wybory?”. Redukcja dystresu związanego z głosami.

5 · EKSPERYMENTY

Łagodne behawioralne testy przekonania: „co by się stało, gdybym...”. Sprawdzenie w bezpiecznych warunkach, z terapeutą.

6 · ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE

Redukcja zachowań zabezpieczających (ang. *safety behaviors*) — np. unikanie miejsc, sprawdzanie. Podtrzymują lęk i przekonania.

02 → Cztery fazy terapii w czasie



Liczba sesji jest orientacyjna — protokół można skrócić lub wydłużyć w zależności od potrzeb.

03 Czego oczekiwać od dobrej terapii CBTp

TERAPEUTA NIE KONFRONTUJE UROJEŃ

Słyszysz: „opowiedz mi więcej”, „rozważmy razem inne możliwości” — nigdy „to nieprawda”. Łagodność jest cechą protokołu, nie słabością.

PRACUJECIE NAD KONKRETEM

Nie „o psychozie ogólnie”, tylko o *tym* głosie, *tej* myśli, *tej* sytuacji w autobusie. Konkretnie jest dźwignią zmiany.

ZADANIA DOMOWE MIĘDZY SESJAMI

Eksperyment, obserwacja, dziennik — coś do zrobienia poza gabinetem. Bez tego CBTp *nie* działa.

CBTP NIE ZASTĘPUJE LEKÓW

U większości osób CBTp jest *uzupełnieniem*, nie zamiennikiem farmakoterapii. Turner (2014): jest skuteczne też bez leków, ale to decyzja podejmowana indywidualnie z psychiatrą.

04 Pytania do terapeuty / psychiatry

Zabierz tę kartę na następną wizytę. Poniżej kilka pytań, które warto zadać. Dopisz własne.

PYTANIA O DOSTĘPNOŚĆ

— czy mam dostęp do CBTP w NFZ / prywatnie

PYTANIA O MOJĄ SYTUACJĘ

— które ze składników 1–6 są dla mnie kluczowe

Klucz: NICE (2014, CG178) rekomenduje CBTP dla **wszystkich** osób z psychozą — nie tylko „opornych na leki” czy „w remisji”. Meta-analiza Wykes i in. (2008): wielkość efektu $d = 0,37$ dla objawów pozytywnych, $d = 0,44$ dla objawów negatywnych. Turner i in. (2014): CBTP skuteczne także u osób odmawiających farmakoterapii. **W Polsce CBTP jest wciąż słabo dostępne** — warto pytać terapeutę, psychiatrę, ośrodek wczesnej interwencji, czy oferują ten protokół.